CENTRO DE PESQUISA INTERPROFISSIONAL EM ULTRASSONOGRAFIA POINT-OF-CARE
CePI-POCUS

ULTRALAB
Laboratório POCUS em Enfermagem
UFPR

Template dos Casos Clínicos PoCUS Game

Elaboração: João Henrique Ribeiro Machado Silva e Yasmin Gonçalves Morais

1. Identificação do caso

Título do caso:

Tema principal:

Área clínica:

Nível de necessidade humana básica afetada, segundo Horta (1979):

1. Avaliação das Necessidades Psicobiológicas
- Regulação do organismo: neurológica, cardiovascular, térmica, hormonal, hidrossalina, eletrolítica, imunológica, celular e vascular
- Oxigenação
- Hidratação
- Nutrição (alimentação)
- Eliminação intestinal e urinária
- Integridade física e cutâneo-mucosa
- Segurança física
- Sono e repouso
- Cuidado corporal
- Sexualidade (aspecto biológico)
- Mecânica corporal, motilidade, locomoção e atividade física
- Percepção sensorial (visual, auditiva, tátil, olfativa, gustativa e dolorosa)
- Abrigo

2. Avaliação das Necessidades Psicossociais
- Comunicação
- Necessidade gregária (viver em grupo, vínculo social)
- Segurança emocional
- Ambiente

3. Avaliação Necessidades Psicoespirituais
- Religião
- Religiosidade
- Espiritualidade

Autor(a):

Data:

2. Objetivo do caso

- **Atente-se em começar a frase com um verbo no infinitivo.**

- Objetivo clínico: Descrever o que se espera que o jogador desenvolva ou aprenda com o caso no aspecto assistencial.
- Objetivo cognitivo: Descrever o que se espera que o jogador desenvolva ou aprenda no aspecto do raciocínio clínico.
- Objetivo técnico: Descrever o que se espera que o jogador aprenda ou desenvolva no aspecto das habilidades no uso do PoCus.

3. Apresentação inicial do paciente - versão técnica

- Identificação: Paciente [sexo], [idade] anos.
- Motivo da internação/atendimento: Descrever o motivo principal da admissão.
- Queixa principal atual: Descrever a queixa ou alteração clínica que motivará a avaliação no caso.
- História clínica resumida: Apresentar de forma objetiva a evolução clínica do paciente até o momento atual. Essa informação será exibida imediatamente ao clicar no paciente, funcionando como um ponto de partida para o jogador.

4. Antecedentes pessoais e clínicos

Comorbidades:

Histórico médico-cirúrgico relevante:

Medicamentos em uso:

- Domiciliar:
- Durante a internação:

Alergias:

Outras informações relevantes:

5. Avaliação clínica atual - (Sinais vitais)

A – Via aérea (Airway)

- Permeabilidade da via aérea:
  - ( ) Pérvia
  - ( ) Parcialmente obstruída
  - ( ) Obstruída
- Presença de:
  - ( ) Secreções
  - ( ) Corpo estranho
- Necessidade de intervenção:
  - ( ) Não
  - ( ) Sim → Qual? _____

B – Respiração (Breathing)

- Frequência respiratória (irpm):
- Saturação de O_2 (%):
- Uso de musculatura acessória:
  - ( ) Sim
  - ( ) Não
- Padrão respiratório:
  - ( ) Eupneico
  - ( ) Taquipneico
  - ( ) Bradipneico
  - ( ) Irregular
- Ausculta pulmonar:
  - ( ) Murmúrio vesicular presente
  - ( ) Reduzido
  - ( ) Estertores
  - ( ) Sibilos
- Expansibilidade torácica:
  - ( ) Simétrica
  - ( ) Assimétrica
- Oxigenoterapia:
  - Tipo: _____
  - Fluxo: _____

C – Circulação (Circulation)

- Frequência cardíaca (bpm):
- Pressão arterial (mmHg):
- Perfusão periférica:
  - Tempo de enchimento capilar: _____ s
  - Extremidades:

        - ( ) Quentes
        - ( ) Frias
- **Pulsos:**
    - ( ) Palpáveis
    - ( ) Filiformes
    - ( ) Ausentes
- **Ritmo cardíaco:**
    - ( ) Regular
    - ( ) Irregular
- **Débito urinário (se disponível):**
- **Presença de edema:**
    - ( ) Sim
    - ( ) Não
- **Temperatura corporal:**

D – Avaliação neurológica (Disability)

- **Nível de consciência:**
    - ( ) Alerta
    - ( ) Responde à voz
    - ( ) Responde à dor
    - ( ) Inconsciente

OU (opcional):

- **Escala de Glasgow: _____**
- **Pupilas:**
    - ( ) Isocóricas
    - ( ) Anisocóricas
    - ( ) Fotorreagentes
    - ( ) Não reagentes
- **Glicemia capilar:**
- **Déficits neurológicos focais:**
    - ( ) Sim
    - ( ) Não

E – Exposição (Exposure)

- **Avaliação da pele:**
    - ( ) Íntegra
    - ( ) Lesões
    - ( ) Cianose
    - ( ) Palidez
    - ( ) Sudorese

- **Presença de:**
    - ( ) Edema
    - ( ) Hemorragias
    - ( ) Lesões por pressão
- **Dor:**
    - Escala (0–10): _____
- **Outros achados relevantes: _____**

AVALIAÇÃO FÍSICA COMPLEMENTAR:

Avaliação abdominal:

Avaliação cardiovascular:

Avaliação musculoesquelética:

6. Dispositivos e suportes em uso

( ) Acesso venoso periférico

( ) Cateter venoso central

( ) Cateter vesical de demora

( ) Sonda enteral

( ) Oxigenoterapia

( ) Ventilação mecânica

( ) Dreno

( ) Monitorização contínua

( ) Outro: _____

7. Dados complementares disponíveis

Se tiver exames laboratoriais, por exemplo, lembre-se de inserir apenas os dados relevantes para o caso.

Por exemplo: Hemoglobina; Leucócitos; Plaquetas; Creatinina; Ureia; Sódio; Potássio; Gasometria arterial/venosa; Outros:

Exames de imagem prévios / Evolução recente / Informações de prontuário: Inserir o que achar pertinente ao caso.

8. Situação-problema do caso

Descrever claramente qual é o problema clínico central apresentado pelo paciente no momento do caso.

Exemplo de estrutura:

“Paciente evolui nas últimas horas com...”, “Durante o plantão, observa-se...”, “Na reavaliação, identifica-se...”.

9. Hipótese clínica principal

Descrever qual é a principal hipótese diagnóstica ou problema clínico a ser reconhecido no caso.

10. Aplicação do POCUS no caso - Qual é o objetivo do POCUS neste caso?

( ) Confirmar hipótese clínica

( ) Guiar procedimento

( ) Complementar avaliação clínica

( ) Monitorar evolução

( ) Guiar conduta

Tipo de avaliação ultrassonográfica esperada:

Estrutura(s) a ser(em) avaliada(s):

Pergunta clínica que o POCUS deve responder:

12. Achados esperados no POCUS

Descrever, de forma objetiva, quais achados ultrassonográficos são esperados neste caso.

Achado principal:

Achados adicionais, se houver:

Inserir as configurações corretas do POCUS para auxiliar os programadores (transdutor certo, posição, preset, etc).

13. Interpretação clínica esperada

Explicar como os achados clínicos e ultrassonográficos devem ser integrados no raciocínio do caso.

14. Conduta esperada

Descrever a conduta mais adequada a partir da avaliação clínica e do POCUS.

15. Evolução esperada do paciente

Descrever o que acontece com o paciente quando a conduta correta é adotada.

16. Possíveis erros ou condutas inadequadas

Listar erros que podem ocorrer na condução do caso.

17. Diagnósticos de Enfermagem

Listar seis opções de diagnósticos, três corretos e três incorretos. Espera-se que o jogador identifique corretamente os diagnósticos prioritários.

18. Intervenções de enfermagem (NIC)

Criar 6 opções de intervenções, três corretas e três incorretas.

19. Feedback educacional/Mensagem final de aprendizagem

Desenvolver mensagens para quando o jogador acertar ou errar, sendo elas sempre com caráter educativo.

Em caso de acerto - Mensagem de reforço positivo + explicação breve: “Parabéns! Você identificou corretamente a obstrução da sonda e realizou a conduta adequada.”

É válido reforçar a conduta correta, validar o raciocínio clínico e ter uma recompensa com pontuação, reposição de vidas perdidas (do jogador).

Em caso de erro - Mensagem explicativa + consequência clínica: “O paciente apresentava sinais clássicos de obstrução da sonda. A ausência de intervenção pode levar a complicações como lesão renal.”

Deve-se explicar o erro de forma didática, apontar riscos clínicos baseados na PBE, sugerir aprofundamento em artigos ou diretrizes (caso tenha) ou sugerir que o jogador acesse a página inicial para revisar os conteúdos disponíveis, aplicar penalidade (perda de pontos ou “vidas” no jogo).

20. Versão narrativa - Desenvolver um texto do caso na versão narrativa do jogo - exemplo: “Você está no plantão da UTI quando recebe um paciente que evolui com dispneia súbita…”

21. Referências que embasam o caso